

表2 初回標準治療例の標準的治療法

原則として RFP, INH, PZA を用いる下記の治療法を用いる。 RFP+INH+PZA に EB（または SM）の 4 剤併用で初期強化期 2 ヶ月間治療後、 維持期は RFP+INH を 4 ヶ月継続し、全治療期間 6 ヶ月（180 日）とする なお、下記の条件がある場合には維持期を 3 ヶ月延長し、維持期を 7 ヶ月、全治療期間 9 ヶ月（270 日）とすることができる。 (1) 結核再治療例 (2) 治療開始時結核が重症：有空洞（特に広汎空洞型）例、粟粒結核、結核性髄膜炎 (3) 排菌陰性化遅延：初期 2 ヶ月の治療後も培養陽性 (4) 免疫低下を伴う合併症：HIV 感染、糖尿病、じん肺、関節リウマチなどの自己免疫疾患 など (5) 免疫抑制薬などの使用：副腎皮質ステロイド薬、その他の免疫抑制薬 (6) その他：骨関節結核で病巣の改善が遷延している場合など

[日本結核病学会治療委員会：結核 93：61-68, 2018 より許諾を得て転載]

るため、いずれかが薬剤耐性あるいは副作用のために使用できない場合は結核専門施設に相談することが望ましい。

治療の中断や不規則な服薬は、治療の失敗、薬剤耐性菌の出現を招くため、医療機関、保健所、調剤薬局などの患者にかかわるさまざまな支援機関が連携し、直接服薬確認、患者の生活などを考慮した一人ひとりの患者に合わせた服薬継続のための支援、DOTS (directly observed treatment, short-course) が実施される。

b 予 後

治療薬剤すべてに感受性である結核菌による若年者の結核では、標準治療を行うことで、再発率は1～2%まで抑えられる。しかし、高齢者の場合、発症時の全身状態が不良であり、治療により結核自体の改善を認めても全身状態が悪化し亡くなることもある。特

に 80 歳以上の高齢者の結核では死亡率が 10% 以上と予後不良である。

Advanced

■多剤耐性結核と超多剤耐性結核

INH と RFP 両方に耐性を示す結核菌による結核は多剤耐性結核 (multi-drug resistant tuberculosis : MDR-TB) と呼ばれる。MDR-TB は難治性で予後不良であり世界的に問題となっているが、近年ではベダキリン、プレトマニド、デラマニドといった新規抗結核薬の登場により治療成績は向上してきている。

文 献

- 1) 日本結核・非結核性抗酸菌症学会（編）：結核診療ガイドライン 2024, 南江堂, 2024
- 2) 日本結核病学会予防委員会：結核 89：717, 2014
- 3) 日本結核病学会治療委員会：結核 93：61, 2018